

Flashcards ENARM -- Psiquiatría

15 patologías · 87 tarjetas · generado 2026-09-12 por La Mole. Frente = pregunta tipo ENARM; Reverso = respuesta + dato diferencial.

Crisis de Angustia (Trastorno de Pánico)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Varón de 28 años con crisis súbitas de palpitaciones, disnea y miedo a morir que alcanzan su punto máximo en pocos minutos. ¿Cuántos síntomas autonómicos exige el diagnóstico de crisis de angustia y cuándo ocurre el pico?

REVERSO: Mínimo 4 síntomas (palpitaciones, sudoración, temblor, disnea, dolor torácico, náusea, mareo, parestesias, entre otros); la crisis alcanza su punto máximo en los primeros 10 minutos. Dato diferencial: el inicio es abrupto y sin desencadenante, a diferencia de la preocupación difusa de la ansiedad generalizada.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento de elección en la fase aguda de una crisis de angustia?

REVERSO: Benzodiacepinas: diazepam, alprazolam, clonazepam o lorazepam. Dato diferencial: la benzodiacepina se usa en el episodio agudo; para el tratamiento a largo plazo la primera línea son los ISRS.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento de primera línea a largo plazo del trastorno de pánico.

REVERSO: ISRS: fluvoxamina, fluoxetina, paroxetina, sertralina o citalopram. Dato diferencial: sin mejoría tras 12 semanas se pasa a un antidepresivo tricíclico.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Paciente con trastorno de pánico sin mejoría tras 12 semanas de ISRS. ¿Cuál es el siguiente escalón farmacológico?

REVERSO: Antidepresivo tricíclico: imipramina o clomipramina. Dato diferencial: informar al paciente la naturaleza de las crisis y que su vida no corre peligro mejora el tratamiento.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué disfunción de neurotransmisión se atribuye a la etiología del trastorno de pánico?

REVERSO: Disfunción noradrenérgica mediada por el locus ceruleus. Dato diferencial: en el TOC la disfunción es serotoninérgica en el circuito orbitofrontal-caudado-tálamo.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Varón de 28 años con crisis súbitas de palpitaciones, disnea y miedo a morir con pico en 10 minutos: diagnóstico y su dato clave.

REVERSO: Crisis de angustia (trastorno de pánico): miedo o incomodidad intensos de inicio abrupto con pico en los primeros 10 minutos y al menos 4 síntomas. Dato diferencial: deben excluirse causas orgánicas de síntomas autonómicos agudos (cardiovasculares y endocrinas).

Delirium

Tarjeta 1 -- FRENTE: Anciano hospitalizado, confundido, con fluctuación diurna. ¿Cuál es la característica esencial del delirium?

REVERSO: Alteración de la atención y la conciencia (orientación reducida al entorno) con un cambio cognitivo adicional, de inicio agudo y curso fluctuante. Dato diferencial: NO son creencias falsas irreductibles (delirios), que son propias de la psicosis y no del delirium.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el curso temporal típico del delirium?

REVERSO: Aparece en horas o pocos días y su gravedad fluctúa a lo largo del día, con empeoramiento por las tardes y noches. Dato diferencial: la demencia inicia de forma insidiosa y progresa de manera estable, sin fluctuación diurna.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué modalidad de alucinaciones es la más típica del delirium?

REVERSO: Las visuales (malinterpretaciones, ilusiones o alucinaciones), aunque pueden aparecer en cualquier modalidad. Dato diferencial: en la esquizofrenia paranoide predominan las alucinaciones auditivas en forma de voces.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Hallazgo electroencefalográfico característico del delirium.

REVERSO: Ralentización generalizada del electroencefalograma; en algunos casos de abstinencia de alcohol aparece actividad rápida. Dato diferencial: el EEG no es suficientemente sensible ni específico para el diagnóstico, y las alteraciones son fisiológicas de una causa médica, sustancia o toxina.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿En qué población es máxima la prevalencia del delirium y qué fármacos lo favorecen?

REVERSO: En ancianos hospitalizados (prevalencia al ingreso de 14-24% y hasta 14% en mayores de 85 años); los fármacos psicoactivos, en especial alcohol y anticolinérgicos, aumentan el riesgo. Dato diferencial: en niños se relaciona con enfermedades febriles y anticolinérgicos.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Clave para distinguir delirium de demencia en un anciano confundido.

REVERSO: Evaluar la atención y el nivel de conciencia: el delirium es agudo, fluctuante y con alteración de la conciencia; la demencia cursa con declive cognitivo estable. Dato diferencial: pueden coexistir, es decir, un delirium superpuesto a un trastorno neurocognitivo preexistente.

Depresión Perinatal (Prenatal y Posparto)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer de 25 años, al tercer día posparto, con llanto fácil y labilidad emotiva. ¿Cuándo debe considerarse depresión posparto verdadera y no melancolía puerperal?

REVERSO: Cuando los síntomas duran más de 2 semanas, están presentes casi todos los días todo el día y hay deterioro funcional; el baby blues aparece entre los días 2-4 posparto y se alivia espontáneamente en 2-3 semanas sin requerir atención. Dato diferencial: el DSM-5 sitúa la depresión posparto dentro de las primeras 4 semanas y la CIE-10 dentro de las primeras 6.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Herramienta de tamizaje preferida para la depresión perinatal y su punto de corte.

REVERSO: Escala de detección de depresión posparto de Edimburgo (EDPE): 10 ítems, máximo 30 puntos; una puntuación >10 sospecha depresión mayor en el periodo prenatal o posparto. Dato diferencial: se aplica por trimestre en el embarazo y en la visita posparto y a las 6-12 semanas tras el parto.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué ítem de la escala de Edimburgo obliga a evaluar el riesgo de suicidio en la mujer perinatal?

REVERSO: El ítem 10 (ideación suicida): cualquier puntaje distinto de 0 obliga a evaluación específica del riesgo suicida y manejo del riesgo inmediato. Dato diferencial: el inventario de Beck >10 también obliga a canalizar a terapia cognitivo conductual.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ISRS contraindicado en el primer trimestre del embarazo y la razón.

REVERSO: Paroxetina, por su asociación con mayor riesgo de defectos cardíacos fetales. Dato diferencial: en general deben evitarse los antidepresivos durante las primeras 12 semanas de gestación, y los ISRS solo se emplean si fracasa el tratamiento no farmacológico.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ISRS de primera línea durante el puerperio y la razón de esa elección.

REVERSO: Sertralina o paroxetina, por su menor excreción en la leche materna en comparación con otros ISRS. Dato diferencial: los ISRS son el grupo de primera elección farmacológica por su favorable relación riesgo-beneficio y mayor seguridad en sobredosis.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Duración del tratamiento con ISRS tras la remisión de un primer episodio de depresión perinatal sin síntomas psicóticos.

REVERSO: De 6 a 9 meses después de la remisión de los síntomas; si es el segundo episodio, mantenimiento de 1 a 2 años. Dato diferencial: la primera línea es no farmacológica (terapia cognitivo conductual) y la TEC se considera ante falta de respuesta a antidepresivos.

Esquizofrenia

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer de 22 años con delirios persecutorios y alucinaciones auditivas de 2 meses de evolución. ¿Cuánto debe durar la alteración para diagnosticar esquizofrenia?

REVERSO: Alteración continua de al menos 6 meses, con al menos 1 mes de ≥ 2 síntomas característicos (delirios, alucinaciones, lenguaje desorganizado, catatonia o síntomas negativos). Dato diferencial: los episodios del estado de ánimo concurrentes deben ser breves frente a las fases activa y residual, para excluir el trastorno esquizoafectivo.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuáles son los síntomas negativos de la esquizofrenia?

REVERSO: Aplanamiento afectivo, alogia, abulia, anhedonia y déficit atencional (ausencia de elementos normales del funcionamiento). Dato diferencial: los síntomas positivos (delirio, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico o desorganizado) son distorsiones por disfunción cerebral.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Subtipo de esquizofrenia más frecuente según la CIE-10 y sus datos clave.

REVERSO: Paranoide: delirios persecutorios, de grandiosidad o ambos, y alucinaciones auditivas relacionadas con el contenido delirante, con cognición y afecto relativamente conservados. Dato diferencial: los temas persecutorios predisponen al suicidio; persecutoria más grandiosidad, a la violencia; mejor respuesta al tratamiento e inicio más tardío.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Subtipo de esquizofrenia con inicio temprano, conducta pueril, afecto plano y peor pronóstico.

REVERSO: Desorganizada (hebefrénica): habla y comportamiento desorganizados, delirios pobres y fragmentarios, personalidad premórbida pobre y curso continuo sin remisiones. Dato diferencial: la catatónica cursa con negativismo, estupor, mutismo, rigidez, catalepsia y flexibilidad cerea.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Paciente esquizofrénico que presenta alucinaciones visuales en forma de microzoopsias. ¿Es este síntoma típico de la esquizofrenia paranoide?

REVERSO: No; en la esquizofrenia paranoide las alucinaciones típicas son auditivas, en forma de voces, relacionadas con el delirio. Dato diferencial: la alucinosis visual (microzoopsias) es típica del alcoholismo.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Manejo farmacológico de la esquizofrenia en fase de mantenimiento.

REVERSO: Antipsicóticos continuados, con psicoeducación familiar y resolución de problemas; en remisión total el antipsicótico se mantiene al menos 1 año antes de intentar un retiro gradual. Dato diferencial: la TEC no forma parte del manejo de la fase de mantenimiento.

Síndrome Neuroléptico Maligno

Tarjeta 1 -- FRENTE: Varón de 45 años, al segundo día de haloperidol, con hipertermia, rigidez generalizada, confusión y taquicardia. ¿Cuál es la tétrada del síndrome neuroléptico maligno?

REVERSO: Hipertermia de 38.5-40 °C, rigidez muscular generalizada en tubo de plomo, alteración del estado mental (confusión, estupor) y disfunción autonómica (taquicardia, hipertensión, diaforesis, incontinencia). Dato diferencial: el inicio es de 1-3 días tras la exposición o cambio de dosis y no es dosis-dependiente.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Dato de laboratorio clave para el diagnóstico del síndrome neuroléptico maligno.

REVERSO: CPK elevada mayor de 1000 U/L; además leucocitosis, mioglobinuria, transaminasas elevadas, acidosis metabólica y rhabdomiólisis. Dato diferencial: en el síndrome serotoninérgico predominan hiperreflexia

y mioclonías, no la rigidez con CPK alta.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Primera medida inmediata ante un síndrome neuroléptico maligno.

REVERSO: Suspender de inmediato el antipsicótico; después soporte con hidratación intravenosa, enfriamiento físico y oxigenación. Dato diferencial: es una reacción idiosincrática por bloqueo dopaminérgico D2, no dosis-dependiente, y puede aparecer a cualquier tiempo de la exposición.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Fármacos del tratamiento del síndrome neuroléptico maligno, con dosis.

REVERSO: Dantroleno 2.5 mg/kg IV (máximo 10 mg/kg/día) como relajante muscular y bromocriptina 2.5-10 mg VO cada 6-8 horas como agonista dopaminérgico; benzodiacepinas para sedación. Dato diferencial: en refractarios se considera TEC o diálisis ante rabdomiólisis severa.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tres claves para diferenciar el síndrome neuroléptico maligno del síndrome serotoninérgico.

REVERSO: Fármaco (antipsicótico bloqueador D2 frente a ISRS, IMAO o triptanos), tiempo de inicio (1-3 días frente a horas) y patrón neuromuscular (rigidez en tubo de plomo de abajo hacia arriba frente a hiperreflexia y mioclonías de arriba hacia abajo). Dato diferencial: el antídoto del serotoninérgico es ciproheptadina, no dantroleno ni bromocriptina.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Mortalidad del síndrome neuroléptico maligno y momento de reiniciar el antipsicótico.

REVERSO: Mortalidad de 10-20% sin tratamiento; la resolución ocurre en 1-2 semanas (más si hubo neuroléptico de depósito) y el antipsicótico se reinicia tras 2-6 semanas con atípicos y vigilancia estrecha. Dato diferencial: el litio potencia el SNM y la supresión de agonistas dopaminérgicos (retiro de levodopa) puede desencadenarlo.

Síndrome Serotoninérgico

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer de 30 años que combina ISRS con tramadol; horas después presenta agitación, taquicardia, midriasis, diarrea, hiperreflexia y mioclonías. ¿Cuál es la triada clínica del síndrome serotoninérgico (criterios de Hunter)?

REVERSO: Neuromuscular (hiperreflexia, mioclonías, clonus, temblor), autonómica (hipertermia, taquicardia, midriasis, diaforesis, diarrea) y mental (agitación, confusión). Dato diferencial: el inicio es en horas, frente a días del síndrome neuroléptico maligno.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Antídoto del síndrome serotoninérgico.

REVERSO: Ciproheptadina, antagonista 5-HT. Dato diferencial: en el síndrome neuroléptico maligno el tratamiento es dantroleno más bromocriptina.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el patrón neuromuscular del síndrome serotoninérgico frente al síndrome neuroléptico maligno?

REVERSO: De arriba hacia abajo: hiperreflexia y mioclonías, mayores en miembros inferiores. Dato diferencial: el SNM cursa con rigidez en tubo de plomo de abajo hacia arriba y sin síntomas gastrointestinales dominantes (la diarrea es frecuente en el serotoninérgico).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Combinaciones farmacológicas que producen síndrome serotoninérgico en el examen.

REVERSO: ISRS o IRSN en sobredosis o combinación; IMAO con tramadol, triptanos o linezolida; también tramadol, linezolida, metadona o MDMA, con litio como potenciador. Dato diferencial: ISRS más tramadol o triptano más mioclonías = síndrome serotoninérgico.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Manejo del síndrome serotoninérgico.

REVERSO: Suspensión del agente serotoninérgico, benzodiacepinas para la agitación, ciproheptadina y soporte (líquidos, enfriamiento, control de hipertensión y taquicardia). Dato diferencial: la primera medida siempre es suspender el fármaco, igual que en el SNM.

Trastorno Bipolar I

Tarjeta 1 -- FRENTE: Rasgo esencial para diagnosticar trastorno bipolar I.

REVERSO: Haber cumplido criterios de al menos un episodio maníaco a lo largo de la vida; los episodios hipomaniacos o depresivos mayores pueden existir, pero no son necesarios para el diagnóstico. Dato diferencial: en el bipolar II hay hipomanía más depresión mayor y nunca manía.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Duración mínima de un episodio maníaco y número de síntomas requeridos.

REVERSO: Mínimo una semana la mayor parte del día casi todos los días (o cualquier duración si se requiere hospitalización), con al menos 3 síntomas (4 si el ánimo es solo irritable). Dato diferencial: la hipomanía dura al menos 4 días consecutivos.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué distingue a un episodio maníaco de uno hipomaniaco?

REVERSO: La manía es grave: causa deterioro importante social o laboral, requiere hospitalización o presenta características psicóticas; la hipomanía nunca lo hace. Dato diferencial: si existen características psicóticas en un episodio hipomaniaco, por definición el episodio es maníaco.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Síntomas que integran el episodio maníaco, además del ánimo elevado.

REVERSO: Grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir (descansado tras solo 3 horas), verborrea con apremio, fuga de ideas, distrabilidad, aumento de actividad dirigida a un objetivo y participación excesiva en actividades de consecuencias dolorosas (compras desenfrenadas, juergas, inversiones imprudentes). Dato diferencial: durante la manía el paciente rara vez reconoce estar enfermo y se resiste al tratamiento.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Riesgo de trastorno bipolar en los familiares de un paciente con bipolaridad.

REVERSO: Riesgo promedio 10 veces superior entre los familiares adultos; aumenta con el grado de parentesco. Dato diferencial: la prevalencia a 12 meses del bipolar I es 0.6% en Estados Unidos y la relación hombres:mujeres es de 1.1:1.

Trastorno Bipolar II

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterios diagnósticos del trastorno bipolar II.

REVERSO: Al menos un episodio hipomaniaco (≥ 4 días consecutivos) y al menos un episodio de depresión mayor (≥ 2 semanas), y nunca ha habido un episodio maníaco. Dato diferencial: si alguna vez hubo manía (o psicosis en el episodio), el diagnóstico es bipolar I.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Duración y límite de gravedad del episodio hipomaniaco.

REVERSO: Al menos 4 días consecutivos de ánimo elevado, expansivo o irritable con aumento de energía, y 3 síntomas (4 si el ánimo es solo irritable), observable por otras personas, pero sin deterioro importante del funcionamiento ni hospitalización. Dato diferencial: las características psicóticas convierten el episodio en maníaco.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Por qué los pacientes con bipolar II suelen consultar durante un episodio depresivo y no por hipomanía?

REVERSO: Porque los episodios hipomaniacos no causan por sí mismos disfunción; el deterioro proviene de los episodios depresivos mayores o del patrón fluctuante del ánimo. Dato diferencial: el bipolar II presenta mayor cronicidad y pasa, en promedio, más tiempo en la fase depresiva que el bipolar I.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Es el trastorno bipolar II una forma leve del bipolar I?

REVERSO: No; a pesar de las diferencias de duración y gravedad entre manía e hipomanía, el bipolar II tiene mayor cronicidad y puede ser grave y discapacitante. Dato diferencial: la impulsividad del bipolar II contribuye a intentos de suicidio y a trastornos por consumo de sustancias.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Diferencia entre trastorno bipolar II y trastorno ciclotímico.

REVERSO: El bipolar II exige al menos un episodio de depresión mayor; en la ciclotimia los periodos de síntomas hipomaniacos y depresivos no reúnen los criterios ni la duración del episodio depresivo mayor. Dato diferencial: el patrón de ciclos rápidos se asocia a peor pronóstico.

Trastorno Depresivo Mayor

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterios DSM del episodio de depresión mayor.

REVERSO: Al menos 5 de 9 síntomas durante el mismo periodo de 2 semanas, incluyendo al menos uno mayor (ánimo deprimido o pérdida de interés/placer), con malestar o deterioro funcional y no atribuible a sustancias ni a enfermedad médica. Dato diferencial: en niños y ancianos el ánimo deprimido puede sustituirse por irritabilidad.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Tratamiento de primera línea de la depresión mayor moderada a severa en el primer nivel de atención.

REVERSO: ISRS (paroxetina, fluoxetina o sertralina) por un periodo mínimo de 6 semanas antes de declarar fracaso terapéutico. Dato diferencial: si fracasa, segunda línea con venlafaxina, anfebutamona, mirtazapina o imipramina.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Indicaciones de terapia electroconvulsiva en el trastorno depresivo mayor.

REVERSO: Depresión refractaria, riesgo suicida y depresión psicótica. Dato diferencial: en la depresión refractaria del tercer nivel pueden adicionarse litio, metilfenidato, anticonvulsivos, antipsicóticos u hormonas tiroideas.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Varón de 68 años, sin antecedentes psiquiátricos, un mes de inquietud, insomnio y verbalizaciones hipocondríacas absurdas ('no puedo comer porque no tengo estómago'). Diagnóstico de presunción.

REVERSO: Depresión psicótica (episodio depresivo mayor con síntomas psicóticos de inicio tardío). Dato diferencial: en el adulto mayor los síntomas psicóticos incluyen ilusiones, delirios de persecución, culpa excesiva y nihilismo; debe distinguirse del inicio de una demencia.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cómo se presenta el trastorno depresivo mayor en el adulto mayor?

REVERSO: Con ansiedad, predominio de síntomas somáticos sobre los afectivos, pérdida de memoria, deterioro cognitivo y síntomas psicóticos (ilusiones, delirios de persecución, sentimientos excesivos de culpa y nihilismo). Dato diferencial: el pico de incidencia de la depresión mayor es entre los 30 y 40 años.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Riesgo de recaída del trastorno depresivo mayor tras la fase aguda.

REVERSO: 25% a las 12 semanas; el inicio temprano, la depresión crónica o más de 3 episodios incrementan el riesgo de recaída temprana. Dato diferencial: el pronóstico empeora con ideas suicidas o estado delirante profundo.

Trastorno Neurocognitivo Mayor

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿A qué entidad del DSM-IV corresponde el trastorno neurocognitivo mayor y cuál es su criterio esencial?

REVERSO: A la demencia: declive cognitivo adquirido en uno o más dominios (atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje y memoria, lenguaje, habilidad perceptual motora o cognición social), documentado por test neuropsicológico, que interfiere con la autonomía en actividades instrumentales complejas. Dato diferencial: los déficits no deben ocurrir exclusivamente en el contexto de un delirium.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Prevalencia de la demencia según la edad.

REVERSO: Aproximadamente 1-2% a los 65 años y hasta 30% a los 85 años; el mayor factor de riesgo es la edad. Dato diferencial: la enfermedad de Alzheimer es rara antes de los 60 años, mientras que la degeneración frontotemporal inicia más temprano.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué modalidad de alucinaciones es más común en los trastornos neurocognitivos que en los trastornos depresivos, bipolares o psicóticos?

REVERSO: Las alucinaciones visuales. Dato diferencial: la paranoia y otros delirios son comunes en las fases leves a moderadas del TNC por enfermedad de Alzheimer, cuerpos de Lewy o degeneración frontotemporal.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Clave para distinguir un trastorno neurocognitivo mayor de un delirium.

REVERSO: La evaluación de la atención y del nivel de conciencia: en el delirium la alteración es aguda, fluctuante y de la conciencia; en el TNC el declive cognitivo es estable y progresivo. Dato diferencial: puede existir un delirium superpuesto a un TNC preexistente (por ejemplo, por enfermedad de Alzheimer).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Patrón de déficits que distingue el TNC por enfermedad de Alzheimer de la depresión mayor del adulto mayor.

REVERSO: En la enfermedad de Alzheimer los déficits de memoria y funciones ejecutivas son sistemáticos; en la depresión mayor el rendimiento es inespecífico o más variable. Dato diferencial: la depresión es común al inicio del curso del TNC por Alzheimer y por Parkinson.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Síntoma comportamental prominente del TNC por degeneración frontotemporal.

REVERSO: La apatía (con desinhibición, hiperfagia y acumulación como otros síntomas del TNC frontotemporal). Dato diferencial: la euforia aparece con más frecuencia en la degeneración frontotemporal, mientras que la depresión es común al inicio en el TNC por Alzheimer y Parkinson.

Trastorno Obsesivo Compulsivo

Tarjeta 1 -- FRENTE: Definición de obsesiones y de compulsiones en el TOC.

REVERSO: Obsesiones: pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes e intrusivos que generan angustia, que el individuo reconoce como producto de su propia mente. Compulsiones: conductas repetitivas (lavarse, ordenar, verificar) o actos mentales (rezar, contar) realizados para prevenir o reducir la angustia. Dato diferencial: en la ansiedad generalizada las preocupaciones son sobre problemas reales de la vida, no intrusivas ni absurdas.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Criterio de tiempo o interferencia exigido para diagnosticar TOC.

REVERSO: Las obsesiones o compulsiones consumen más de 1 hora al día, causan angustia notable o interfieren significativamente en la rutina, el desempeño ocupacional o académico o las relaciones. Dato diferencial: en algún momento el paciente reconoce que son excesivas o irracionales (excepto en niños).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento de primera línea del TOC.

REVERSO: ISRS: fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina o sertralina. Dato diferencial: la segunda línea es clomipramina (además de venlafaxina y citalopram).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento de segunda línea del TOC.

REVERSO: Clomipramina (también venlafaxina y citalopram). Dato diferencial: la tercera línea es clomipramina intravenosa o escitalopram.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué circuito neural y neurotransmisor se alteran en el TOC?

REVERSO: La transmisión serotoninérgica en el circuito corteza orbitofrontal-núcleo caudado-globos pálido-tálamo. Dato diferencial: en el trastorno de pánico la disfunción es noradrenérgica del locus ceruleus.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Epidemiología del TOC.

REVERSO: Riesgo de presentar el trastorno a lo largo de la vida de 2.5% en población general, con pico de incidencia a los 30 años. Dato diferencial: si el contenido obsesivo se explica por otro trastorno (comida en TCA, apariencia en dismórfico corporal, cabello en tricotilomanía), no se diagnostica TOC.

Trastorno de Ansiedad Generalizada

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterios esenciales del trastorno de ansiedad generalizada.

REVERSO: Ansiedad y preocupación excesiva sobre una gama amplia de acontecimientos, difícil de controlar, asociada a ≥ 3 síntomas (inquietud, fatigabilidad, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, alteración del sueño), con malestar o deterioro funcional. Dato diferencial: el centro de la ansiedad no se limita a los síntomas de otro trastorno.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Duración exigida para los síntomas del TAG.

REVERSO: Algunos de los síntomas deben estar presentes más de 6 meses. Dato diferencial: la preocupación es difusa y constante, a diferencia del miedo súbito y paroxístico de la crisis de angustia.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento de sostén del TAG.

REVERSO: ISRS: sertralina, citalopram, paroxetina o escitalopram. Dato diferencial: las benzodiacepinas (alprazolam, lorazepam, diazepam) son solo tratamiento inicial breve, y al lograr remisión el ISRS se retira de forma gradual.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Paciente con TAG sin mejoría tras 8-12 semanas de ISRS. ¿Cuál es el siguiente escalón?

REVERSO: Inhibidor de la recaptura de noradrenalina (venlafaxina) o imipramina. Dato diferencial: la venlafaxina no se recomienda en pacientes con cardiopatías.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Paciente con TAG y antecedente de abuso de sustancias o toxicomanías: fármaco de elección.

REVERSO: Buspirona, en lugar de benzodiacepinas. Dato diferencial: las benzodiacepinas se evitan en estos pacientes por el riesgo de abuso.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Herramienta diagnóstica del TAG en el adulto mayor y su punto de corte.

REVERSO: Inventario de Ansiedad Geriátrica (GAI): 20 enunciados sobre la semana previa, con punto de corte diagnóstico de 8. Dato diferencial: en el anciano predominan irritabilidad, preocupación excesiva difícil de controlar y quejas somáticas (taquipnea, síntomas gastrointestinales, tensión muscular).

Trastorno de Estrés Postraumático

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterio A del TEPT: ¿qué exposiciones califican como trauma?

REVERSO: Exposición real o amenaza de muerte, lesión grave o violencia sexual, por experiencia directa, presenciarlo, enterarse de que ocurrió a un familiar o amigo íntimo, o exposición repetida y extrema a detalles repulsivos (socorristas, policías). Dato diferencial: la exposición por medios electrónicos, televisión o fotografías no cuenta, salvo que esté relacionada con el trabajo.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuáles son los 4 grupos de síntomas del TEPT?

REVERSO: Intrusión (recuerdos intrusivos, pesadillas, escenas retrospectivas), evitación persistente (pensamientos internos y recordatorios externos), alteraciones negativas de la cognición y el ánimo (culpa, desapego, anhedonia) y alteración de la alerta y reactividad (hipervigilancia, sobresalto exagerado). Dato diferencial: la duración debe ser mayor de un mes.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Diferencia entre TEPT y trastorno de estrés agudo.

REVERSO: El trastorno de estrés agudo se limita a entre 3 días y 1 mes después del trauma; el TEPT dura más de un mes. Dato diferencial: si los criterios completos no se cumplen hasta al menos 6 meses después del evento, el TEPT es con expresión retardada.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Especificadores diagnósticos del TEPT.

REVERSO: Con síntomas disociativos (despersonalización o desrealización persistentes o recurrentes) y con expresión retardada (criterios completos hasta ≥ 6 meses después del acontecimiento). Dato diferencial: las escenas retrospectivas (flashbacks) son reacciones disociativas en las que el sujeto actúa como si el suceso se repitiera.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Poblaciones con las tasas más altas de TEPT.

REVERSO: Supervivientes de violación, combate militar, cautiverio e internamiento y genocidio: de un tercio a más de la mitad de los expuestos. Dato diferencial: la prevalencia anual en adultos de Estados Unidos es de 3.5% y el riesgo vital de 8.7% a los 75 años.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Factores que aumentan el riesgo de desarrollar TEPT.

REVERSO: Sexo femenino, edad joven al trauma, trauma previo (especialmente en la niñez), trastornos mentales previos (pánico, depresión, TOC), gravedad del trauma y violencia interpersonal. Dato diferencial: el apoyo social es el factor protector que modera el resultado postraumático.

Trastornos Disociativos

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterios del trastorno de identidad disociativo.

REVERSO: Dos o más estados de personalidad bien definidos (o experiencia de posesión) con discontinuidad del sentido del yo, más lapsos recurrentes de memoria de acontecimientos cotidianos, información personal o sucesos traumáticos, incompatibles con el olvido ordinario. Dato diferencial: deben excluirse los efectos de sustancias (laguna mental en intoxicación) y la epilepsia parcial compleja.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Epidemiología y etiología del trastorno de identidad disociativo.

REVERSO: Prevalencia a 12 meses de 1.5% en adultos de Estados Unidos, y aproximadamente 90% de los casos tienen antecedente de abuso infantil y negligencia (físico o sexual). Dato diferencial: el abuso continuo, la retraumatización y el retraso en el tratamiento se asocian a peor pronóstico.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tipos de amnesia disociativa.

REVERSO: Localizada (de un evento o periodo), selectiva (de un aspecto del evento) o generalizada (de la identidad y la historia vital). Dato diferencial: el déficit es de la información autobiográfica con capacidades intelectuales y cognitivas conservadas, a diferencia de los trastornos neurocognitivos.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué es la fuga disociativa?

REVERSO: Un especificador de la amnesia disociativa: recorridos con propósito o vagar desorientado que acompañan la amnesia. Dato diferencial: la amnesia de la fuga disociativa suele ser particularmente resistente al tratamiento.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Mujer de 24 años con sensación persistente de ser observadora externa de su propio cuerpo y de que el mundo parece un sueño, pero sabe que su experiencia es irreal. Diagnóstico y clave diferencial.

REVERSO: Trastorno de despersonalización/desrealización: las pruebas de realidad se mantienen intactas durante los episodios. Dato diferencial: si se pierde el juicio de realidad se orienta a trastorno psicótico, y los síntomas que aparecen solo durante ataques de pánico no corresponden a este trastorno.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué significa 'amnesia de su amnesia' en los trastornos disociativos?

REVERSO: La mayoría de los pacientes no reconoce sus lagunas mnésicas hasta que pierde la identidad personal o las circunstancias lo hacen evidente. Dato diferencial: en el trastorno de identidad disociativo las

amnesias incluyen posesiones inexplicables y fluctuaciones bruscas de habilidades y conocimiento.

Trastornos de la Conducta Alimentaria

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterios diagnósticos de la anorexia nerviosa.

REVERSO: Restricción de la ingesta energética con peso corporal significativamente bajo, miedo intenso a ganar peso o comportamiento que interfiere en el aumento de peso, y alteración de la percepción del propio peso o constitución. Dato diferencial: se especifica tipo restrictivo o con atracones/purgas.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Hallazgos clínicos y constantes vitales frecuentes en la anorexia nerviosa.

REVERSO: Amenorrea frecuente, hipotensión, hipotermia y bradicardia; los vómitos, laxantes, diuréticos y enemas generan resultados analíticos anormales. Dato diferencial: en la bulimia nerviosa el peso suele ser normal o de sobrepeso.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿La anorexia nerviosa comienza siempre después de la pubertad?

REVERSO: No; el inicio puede ocurrir antes de la pubertad (afirmación falsa). Dato diferencial: la pérdida significativa de peso corresponde a un índice de Quetelet menor de 17.5, con trastorno endocrino hipotálamo-hipofisario-gonadal.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Criterios diagnósticos de la bulimia nerviosa.

REVERSO: Atracónes recurrentes más comportamientos compensatorios inapropiados (vómito autoprovocado, laxantes, diuréticos, ayuno, ejercicio excesivo), en promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses, con autoevaluación indebidamente influida por el peso. Dato diferencial: a diferencia de la anorexia, el peso se mantiene igual o mayor que el límite inferior normal.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Mujer de 21 años con bulimia nerviosa y vómitos autoprovocados. ¿Cuál es la prueba más útil para evaluar la gravedad?

REVERSO: La amilasa plasmática. Dato diferencial: las alteraciones hidroelectrolíticas por purga pueden ser graves; complicaciones raras y potencialmente mortales: desgarros esofágicos, perforación gástrica y arritmias cardíacas.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Diferencia entre bulimia nerviosa y trastorno de atracones.

REVERSO: El trastorno de atracones no se acompaña de comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes; ambos exigen atracones en promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. Dato diferencial: la bulimia no se diagnostica exclusivamente durante episodios de anorexia nerviosa.